Bệnh tế bào hình lưỡi liềm

Một nghiên cứu nhãn mở, đơn nhánh (6096A1-3014 [B1851013]) với 2 liều Prevenar 13 được tiêm cách nhau 6 tháng được tiến hành ở 158 trẻ em và thiếu niên ≥6 đến <18 tuổi bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm, đã được tiêm chủng trước đó tối thiểu 1 liều PPSV23 ít nhất 6 tháng trước khi ghi danh. Sau khi tiêm chủng lần đầu, Prevenar 13 đã sinh ra nồng độ kháng thể được đo bằng cả nồng độ trung bình nhân (GMC) của IgG và hiệu giá trung bình nhân (GMT) của OPA, các giá trị này cao hơn đáng kể về thống kê khi so sánh với nồng độ trước khi tiêm chủng. Sau liều thứ hai đáp ứng miễn dịch tương đương với đáp ứng sau liều đầu tiên. Một (1) năm sau liều thứ hai, nồng độ kháng thể đo bằng cả GMC của IgG và GMT của OPA cao hơn so với nồng độ trước liều Prevenar 13 đầu tiên, ngoại trừ GMC của IgG với týp huyết thanh 3 là tương đương.

Dữ liệu bổ sung trên vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn: trẻ em có bệnh tế bào hình lưỡi liềm

Tính sinh miễn dịch của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn đã được đánh giá trong một nghiên cứu nhãn mở, đa trung tâm (0887X1-100722) ở 49 trẻ sơ sinh bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm. Trẻ em được tiêm bằng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (3 liều cách nhau 1 tháng từ 2 tháng tuổi) và 46 trong số trẻ em này cũng được tiêm PPSV23 ở 15-18 tháng tuổi. Sau lần tiêm chủng chính, 95,6% các đối tượng có mức độ kháng thể > 0,35 µg/ml cho tất cả 7 týp huyết thanh có trong vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn. Một sự gia tăng đáng kể nồng độ kháng thể được quan sát thấy đối với 7 týp huyết thanh sau khi tiêm PPSV23, điều này cho thấy trí nhớ miễn dịch đã được thiết lập tốt.

Nhiễm HIV

Trẻ em và người lớn trước đó chưa được tiêm chủng vắc xin phế cầu khuẩn

Trong nghiên cứu 6115A1-3002 (B1851021), trẻ em và người lớn nhiễm HIV (CD4 ≥200 tế bào/µL, nồng độ virus trong máu <50,000 phiên bản/ml và không có bệnh liên quan đến AIDS đang hoạt động) trước đây chưa được tiêm vắc xin phế cầu khuẩn được tiêm 3 liều Prevenar 13. Theo khuyến cáo chung, một liều đơn PPSV23 sau đó đã được cho dùng. Vắc xin được tiêm cách nhau 1 tháng. Đáp ứng miễn dịch được thẩm định ở 259-270 đối tượng có thể đánh giá được khoảng 1 tháng sau mỗi liều vắc xin. Sau liều đầu tiên, Prevenar 13 sinh ra nồng độ kháng thể, đo bằng cả GMC của IgG và GMT của OPA, các giá trị này cao hơn đáng kể về thống kê so với nồng độ trước khi tiêm chủng. Sau liều Prevenar 13 thứ hai và thứ ba, đáp ứng miễn dịch tương tự hoặc cao hơn so với đáp ứng sau liều đầu tiên.

Người lớn trước đó đã được tiêm chủng vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn

Trong nghiên cứu 6115A1-3017 (B1851028), đáp ứng miễn dịch được thẩm định ở 329 người lớn nhiễm HIV ≥18 tuổi (số tế bào T CD4+ ≥200 tế bào/µL và nồng độ virus trong máu <50,000 phiên bản/ml) trước đây được tiêm phòng với PPSV23 ít nhất 6 tháng trước khi ghi danh. Đối tượng được nhận 3 liều Prevenar 13, khi ghi danh, 6 tháng và 12 tháng sau liều Prevenar 13 đầu tiên. Sau lần tiêm chủng đầu tiên, Prevenar 13 sinh ra nồng độ kháng thể đo bằng cả GMC của IgG và GMT của OPA, các giá trị này đều cao hơn đáng kể về thống kê khi so sánh với nồng độ trước khi tiêm chủng. Sau liều Prevenar 13 thứ hai và thứ ba, đáp ứng miễn dịch tương đương hoặc cao hơn so với đáp ứng sau liều đầu tiên. Các đối tượng đã nhận tối thiểu 2 liều PPSV23 trước đây thể hiện đáp ứng miễn dịch tương tự so với các đối tượng nhận một liều đơn trước đây.